

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch ^{Rx} PARACETAMOL 10mg/ml

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc này chỉ sử dụng theo đơn thuốc THÀNH PHAN

Mỗi ml dung dịch truyền tĩnh mạch PARACETAMOL 10mg/ml chứa: Paracetamol 10 mg; Tá dược (Cystein, natri metabisulfít, dinatri edetat, manitol, dinatri hydrophosphat, acid hydrochlorid, nước cất pha tiêm) vừa đủ 1 ml

DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch.

DƯỢC LỰC HỌC

- **Phân nhóm được lý:** Giảm đau; hạ sốt.

- **Mã ATC:** N02BE01

Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu có thể thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin, Paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, Paracetamol có tác dụng giảm đau và hạ sốt tương tự như aspirin. Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên.

Với liều điều trị, Paracetamol ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid-base, không gây kích ứng, loét hoặc chảy máu dạ dày như khi dùng salicylat. Tác dụng của Paracetamol trên hoạt tính cyclooxygenase chưa được biết đầy đủ. Với liều 1 g/ngày, Paracetamol ức chế cyclooxygenase yếu và có tác dụng ức chế trên cyclooxygenase - 1 yếu. Paracetamol thường được chọn làm thuốc giảm đau và hạ sốt, đặc biệt ở người cao tuổi và ở người có chống chỉ định dùng salicylat hoặc NSAID khác như người bị hen, có tiền sử loét dạ dày tá tràng, trẻ em.

Paracetamol không có tác dụng trên sự kết tập tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Với liều điều trị, Paracetamol chuyển hóa chủ yếu qua phản ứng liên hợp sulfat và glucuronid. Một lượng nhỏ thường chuyển thành một chất chuyển hóa độc, N-acetyl-p-benzoquinonimin (NAPQI). NAPQI được khử độc bằng glutathion và đào thải vào nước tiểu và/hoặc mật. Khi chất chuyển hóa không được liên hợp với glutathion sẽ gây độc cho các tế bào gan và gây hoại tử tế bào.

Paracetamol thường an toàn khi dùng với liều điều trị, vì lượng NAPQI được tạo thành tương đối ít và glutathion dự trữ trong tế bào gan đủ liên hợp với NAPQI. Tuy nhiên, khi quá liều hoặc đôi khi với liều thường dùng ở một số người nhạy cảm (như suy dinh dưỡng, hoặc tương tác thuốc, nghiện rượu, cơ địa di truyền), nồng độ NAPQI có thể tích lũy gây độc cho gan.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- **Hấp thu:** thuốc được truyền trực tiếp qua tĩnh mạch vào máu. Nồng độ tối đa của Paracetamol trong huyết tương đạt được sau khi tiêm tĩnh mạch 15 phút khoảng 30 mcg/ml

- **Phân bố:** Paracetamol phân bố nhanh, đồng đều trong phần lớn các mô của cơ thể. Khoảng 25% Paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương. Thể tích phân bố của Paracetamol xấp xỉ 1 lít/kg. 20 phút sau khi tiêm 1000mg Paracetamol, nồng độ trong dịch não tủy khoảng 1,5 µg/ml.

- **Thải trừ:** Nửa đời huyết tương của Paracetamol là 1,25 - 3 giờ, có thể kéo dài với liều gây độc hoặc ở người bệnh có thương tổn gan. Sau liều điều trị, có thể tìm thấy 90 - 100% thuốc trong nước tiểu trong ngày thứ nhất, chủ yếu sau khi liên hợp trong gan với acid glucuronic (khoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 35%) hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyển hóa hydroxyl - hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.

Paracetamol bị N-hydroxyl hóa bởi cytochrom P450 để tạo nên N-acetyl-benzoquinonimin (NAPQ), một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hóa này bình thường phản ứng với các nhóm sulfhydryl trong glutathion và bị khử hoạt tính. Tuy nhiên, nếu uống liều cao Paracetamol, chất chuyển hóa này được tạo thành với lượng đủ để làm cạn kiệt glutathion của gan, trong tình trạng đó, chất NAPQ không được liên hợp với glutathion và có tác hại gây độc cho tế bào gan, dẫn đến viêm gan và có thể dẫn đến hoại tử gan.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 túi 100 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. Hộp 1 chai 100 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Thùng 48 túi 100 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. Thùng 48 chai 100 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chỉ Định: Paracetamol được dùng trong điều trị đau nhẹ đến vừa và sốt.

- Paracetamol được dùng giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa. Thuốc có hiệu quả nhất là làm giảm đau cường độ thấp có nguồn gốc không phải nội tạng.

- Paracetamol không có tác dụng trị thấp khớp. Paracetamol là thuốc thay thế salicylat (ở người bệnh chống chỉ định hoặc không dung nạp salicylat) để giảm đau nhẹ hoặc hạ sốt.

- Paracetamol thường được dùng để giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt do mọi nguyên nhân nhưng không làm giảm thân nhiệt ở người bình thường. Tuy vậy, liệu pháp hạ sốt nói chung không đặc hiệu, không ảnh hưởng đến tiến trình của bệnh cơ bản, và có thể che lấp tình trạng bệnh của người bệnh.

Liều Dùng

Cách dùng:

- Trước khi sử dụng, cần quan sát kiểm tra xem sản phẩm có bị vẩn đục hoặc đổi màu.

- Chỉ sử dụng một lần. Dung dịch còn lại không sử dụng hết phải bỏ đi.

- Tiêm truyền tĩnh mạch trong 15 phút.

- Khoảng cách giữa 2 lần truyền thuốc tối thiểu là 4 giờ.

- Không được dùng Paracetamol để tự điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn hoặc quá 5 ngày ở trẻ em, trừ khi do thầy thuốc hướng dẫn, vì đau nhiều và kéo dài như vậy có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị có giám sát bởi thầy thuốc.

- Không dùng Paracetamol cho người lớn và trẻ em để tự điều trị sốt cao (trên 39,5 độ C), sốt kéo dài trên 3 ngày, hoặc sốt tái phát, trừ khi do thầy thuốc hướng dẫn, vì sốt như vậy có thể là dấu hiệu của một bệnh nặng cần được thầy thuốc chẩn đoán nhanh chóng.

Liều lượng:

a - Người lớn: Truyền tĩnh mạch trong 15 phút. Liều được tính theo cân nặng như sau:

- **Trên 50 kg:**

+ Liều một lần truyền là 1000mg / lần truyền.

+ Cứ cách 4 giờ - 6 giờ truyền một liều 1000mg, liều tối đa là 4000mg /ngày.

Có thể sử dụng túi 100ml sản phẩm PARACETAMOL 10mg/ml chứa 1000mg hoặc 2 túi 50ml sản phẩm PARACETAMOL 10mg/ml mỗi túi 50ml chứa 500mg

+ **Suy thận:** CL < 30 ml/phút, giảm liều hàng ngày hoặc giãn rộng khoảng cách truyền giữa 2 lần truyền

+ **Suy gan:** dùng thận trọng, dùng liều thấp. Tránh dùng kéo dài.

Với trường hợp suy gan, suy thận, tùy thuộc chỉ định của bác sĩ điều trị về giảm liều, sử dụng liều thấp, giãn rộng khoảng cách tiêm truyền, có thể sử dụng sản phẩm PARACETAMOL 10mg/ml với đóng gói túi 90ml chứa 900mg / túi hoặc túi 75ml chứa 750mg /túi, thay cho túi 100ml chứa 1000mg /lần truyền.

- **Dưới 50 kg:**

+ Liều một lần truyền là 15 mg/kg, cứ cách 6 giờ truyền một lần; Tối đa là 60 mg/kg/ngày (*)

+ **Bệnh nhân nghiện rượu, suy dinh dưỡng mạn, bị mất nước:** Không vượt quá liều tối đa 3000mg/24 giờ (*)
Tùy thuộc chỉ định của bác sĩ điều trị, người lớn có cân nặng < 50kg, có thể sử dụng sản phẩm PARACETAMOL 10mg/ml với đóng gói túi 50ml chứa 500mg hoặc túi 75ml chứa 750mg cho 1 lần truyền. Tối đa không quá 6 túi 50ml chứa 500mg /túi hoặc 4 túi 75ml chứa 750mg/túi/ trong 24 giờ.

b - Trẻ em:

Truyền tĩnh mạch trong 15 phút: Liều được tính theo cân nặng:

Trẻ sinh non trên 32 tuần: 7,5mg/kg cách 8 giờ/lần. Liều tối đa 25 mg/kg/24 giờ.

Trẻ sơ sinh: 10 mg/kg cách 4–6 giờ/lần. Liều tối đa 30 mg/24 giờ.

Trẻ em có thể trọng dưới 10kg: 10 mg/kg cách 4–6 giờ/lần. Liều tối đa 30 mg/24 giờ.

Trẻ em có thể trọng từ 10–50kg: 15 mg/kg cách 4–6 giờ/lần. Liều tối đa 60 mg/24 giờ.

Trẻ em có thể trọng trên 50kg: dùng liều như người lớn.

Suy thận: CL < 30 ml/phút, giảm liều hàng ngày hoặc giãn rộng khoảng cách truyền giữa 2 lần truyền.

Suy gan: dùng thận trọng, dùng liều thấp. Tránh dùng kéo dài.

Chống Chỉ Định: Quá mẫn với Paracetamol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Suy gan nặng.

CÁC TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Paracetamol (acetaminophen) tương đối không độc với liều điều trị và khi dùng dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc. Tuy nhiên, dùng quá liều Paracetamol là nguyên nhân chính gây suy gan cấp. Dùng nhiều chế phẩm chứa Paracetamol đồng thời có thể dẫn đến hậu quả có hại (như quá liều Paracetamol). Phản ứng da nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong bao gồm hội chứng Stevens-Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân (AGEP: Acute generalized exanthematous), hội chứng Lyell tuy hiếm nhưng đã xảy ra với Paracetamol, thường không phụ thuộc vào tác dụng của các thuốc khác. Các thuốc giảm đau và hạ sốt khác (như NSAID) có thể gây các phản ứng tương tự, mẫn cảm chéo với Paracetamol là không xảy ra. Người bệnh cần phải ngừng dùng Paracetamol và đi khám thầy thuốc ngay khi thấy phát ban hoặc các biểu hiện khác ở da hoặc các phản ứng mẫn cảm trong khi điều trị. Người bệnh có tiền sử có các phản ứng như vậy không dùng các chế phẩm chứa Paracetamol.

Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát sần ngứa và mảy dầy, những phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra với việc sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng Paracetamol. Hiếm gặp mắt bạch cầu hạt ở người bệnh dùng Paracetamol.

Một số dạng thuốc Paracetamol có trên thị trường chứa sulfít có thể gây phản ứng kiểu dị ứng, gồm cả phản vệ và những cơn hen đe dọa tính mạng hoặc ít nghiêm trọng hơn ở một số người quá mẫn. Thường gặp ở người bệnh hen nhiều hơn ở người không hen. Phải thận trọng khi dùng Paracetamol cho người bị suy gan, suy thận, người nghiện rượu, suy dinh dưỡng mạn tính hoặc bị mất nước. Tránh dùng liều cao, dùng kéo dài và dùng theo đường tĩnh mạch cho người bị suy gan.

Phải dùng Paracetamol thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù nồng độ cao ở mức nguy hiểm của methemoglobin trong máu. Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của Paracetamol, nên tránh hoặc hạn chế uống rượu.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc

Phản ứng phụ nghiêm trọng trên da mặc dù ít lệ mắc phải là không cao nhưng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng bao gồm hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc: toxic epidermal necrolysis (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính: acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP).

✓ *Triệu chứng của các hội chứng nêu trên được mô tả như sau:*

- Hội chứng Stevens-Johnson (SJS): là dị ứng thuốc thể bong nước, bong nước khu trú ở quanh các hốc tự nhiên như mắt, mũi, miệng, tai, bộ phận sinh dục và hậu môn. Ngoài ra có thể kèm sốt cao, viêm phổi, rối loạn chức năng gan thận. Chẩn đoán hội chứng Stevens-Johnson (SJS) khi có ít nhất 2 hốc tự nhiên bị tổn thương.
- Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) là thể dị ứng thuốc nặng nhất, gồm:
 - + Các tổn thương da dạng ở da: ban dạng sởi, ban dạng tính hồng nhiệt, hồng ban hoặc các bong nước bồng nhúng, các tổn thương nhanh chóng lan tỏa khắp người;
 - + Tổn thương niêm mạc mắt: viêm giác mạc, viêm kết mạc mù, loét giác mạc.
 - + Tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa: viêm miệng, loét niêm mạc miệng, loét hầu, họng thực quản, dạ dày, ruột.
 - + Tổn thương niêm mạc đường sinh dục, tiết niệu.
- + Ngoài ra còn có các triệu chứng toàn thân trầm trọng như sốt, xuất huyết đường tiêu hóa, viêm phổi, viêm cầu thận, viêm gan... tỷ lệ tử vong cao 15-30%.
- Hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP): mụn mủ vô trùng nhỏ phát sinh trên nền hồng ban lan rộng. Tổn thương thường xuất hiện ở các nếp gấp như nách, bẹn và mặt, sau đó có thể lan rộng toàn thân. Triệu chứng toàn thân thường có là sốt, xét nghiệm máu bạch cầu mủ trung tính tăng cao.

✓ Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bị các phản ứng trên da nghiêm trọng do Paracetamol gây ra thì không được dùng thuốc trở lại và khi đến khám chữa bệnh cần phải thông báo cho nhân viên y tế biết về vấn đề này.

Lưu ý: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của các phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hoại tử da nhiễm độc (TEN), Lyell, ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa xác định được tính an toàn của Paracetamol dùng khi thai nghén liên quan đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng Paracetamol ở người mang thai khi thật cần.

- Nghiên cứu ở người mẹ dùng Paracetamol đang cho con bú, không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VIỆC HÀNH MÁY MÓC: Không có **TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC**

- Thuốc uống chống đông máu: Sử dụng dài ngày Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn chất indandion. Dữ liệu nghiên cứu còn mâu thuẫn nhau và còn nghi ngờ về tương tác này, nên Paracetamol được ưa dùng hơn salicylat khi cần giảm đau nhẹ hoặc hạ sốt cho người bệnh đang dùng coumarin hoặc dẫn chất indandion.
- Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ thân nhiệt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt (như Paracetamol).
- Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ gây độc cho gan của Paracetamol.
- Thuốc chống co giật (gồm phenytoin, barbiturat, carbamazepin) gây cảm ứng enzym ở microsom gan, có thể làm tăng tính độc hại gan của Paracetamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan. Ngoài ra, dùng đồng thời isoniazid với Paracetamol cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan, nhưng chưa xác định được cơ chế chính xác của tương tác này.
- Nguy cơ Paracetamol gây độc tính gan gia tăng đáng kể ở người bệnh uống liều Paracetamol lớn hơn liều khuyến dùng trong khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid. Thường không cần giảm liều ở người bệnh dùng đồng thời liều điều trị Paracetamol và thuốc chống co giật, tuy vậy, người bệnh phải hạn chế tự dùng Paracetamol khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazid.
- Probenecid có thể làm giảm đào thải Paracetamol và làm tăng thời gian nửa đời trong huyết tương của Paracetamol.
- Isoniazid và các thuốc chống lao làm tăng độc tính của Paracetamol đối với gan.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Phản ứng da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson, hội chứng Lyell, hoại tử biểu bì nhiễm độc, mụn mủ ban đỏ toàn thân cấp tuy hiếm xảy ra, nhưng có khả năng gây tử vong. Nếu thấy xuất hiện ban hoặc các biểu hiện khác về da, phải ngừng dùng thuốc và thăm khám thầy thuốc.

Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mề đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thường tổn niêm mạc. Nếu thấy sốt, bong nước quanh các hốc tự nhiên, nên nghĩ đến hội chứng Stevens-Johnson, phải ngừng

thuốc ngay. Quá liều Paracetamol có thể dẫn đến tổn thương gan nặng và đôi khi hoại tử ống thận cấp. Người bệnh mẫn cảm với salicylat hiếm khi mẫn cảm với Paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, Paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.

- **Ỉt gặp, 1/1000 <ADR < 1/100:**

+ Da: Ban.

+ Dạ dày - ruột: Buồn nôn, nôn.

+ Huyết học: Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiếu máu.

+ Thận: Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

- **Hiếm gặp, ADR < 1/1000:**

+ Khác: Phản ứng quá mẫn.

+ Nếu xảy ra những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng thông báo ngay cho bác sĩ điều trị.

♦ *Hướng dẫn cách xử trí ADR:*

Nếu xảy ra những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng thông báo ngay cho bác sĩ điều trị.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Biểu hiện

- Nhiễm độc Paracetamol có thể do dùng một liều duy nhất, hoặc do dùng lặp lại liều lớn Paracetamol (ví dụ, 7,5 - 10 g mỗi ngày, trong 1 - 2 ngày), hoặc do sử dụng thuốc dài ngày. Hoại tử gan phụ thuộc liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể gây tử vong.
- Buồn nôn, nôn, và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 - 3 giờ sau khi sử dụng liều độc của thuốc. Methemoglobin máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay là một dấu hiệu độc trung nhiễm độc cấp tính dẫn chất p-aminophenol, một lượng nhỏ sulfhemoglobin cũng có thể được sản sinh. Trẻ em có khuynh hướng tạo methemoglobin dễ hơn người lớn.
- Khi bị ngộ độc nặng, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động, và mê sảng. Tiếp theo có thể là ức chế hệ thần kinh trung ương: sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhanh, yếu, không đều, huyết áp thấp và suy tuần hoàn. Truy mạch do giảm oxy huyết tương đối và do tác dụng ức chế trung tâm, tác dụng này chỉ xảy ra với liều rất lớn. Sốc có thể xảy ra nếu giãn mạch nhiều.
- Con co giật nhẹ thở gây tử vong có thể xảy ra. Thường hơn mê xảy ra trước khi chết đột ngột hoặc sau vài ngày hôn mê. Dấu hiệu lâm sàng thường tổn gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều độc. Aminotransferase huyết tương tăng (đôi khi tăng rất cao) và nồng độ bilirubin trong huyết tương cũng có thể tăng, thêm nữa, khi thương tổn gan lan rộng, thời gian prothrombin sẽ kéo dài.
- Có thể 10% người bệnh bị ngộ độc không được điều trị đặc hiệu đã có thương tổn gan nghiêm trọng; trong số đó 10% đến 20% cuối cùng chết vì suy gan. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh. Sinh thiết gan phát hiện hoại tử trung tâm tiểu thùy từ vùng quanh tĩnh mạch cửa. Ở những trường hợp không tử vong, thương tổn gan phục hồi sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Điều trị

- Chẩn đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều Paracetamol. Có những phương pháp xác định nhanh nồng độ thuốc trong huyết tương.
- Tuy vậy, không được trì hoãn điều trị trong khi chờ kết quả xét nghiệm nếu bệnh sử gợi ý là quá liều nặng. Khi nhiễm độc nặng, điều quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực.
- Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ sung dự trữ glutathion ở gan.
- N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Phải cho thuốc ngay lập tức nếu chưa đến 36 giờ kể từ khi uống Paracetamol. Hiệu quả cao hơn khi dùng N - acetylcystein trong 10 giờ sau khi uống Paracetamol. Khi cho uống, pha dung dịch N - acetylcystein 5% với nước hoặc đồ uống không có cồn, uống trong vòng 1 giờ sau khi pha. Cho uống N-acetylcystein với liều đầu tiên là 140 mg/kg, sau đó cho tiếp 17 liều nữa, mỗi liều 70 mg/kg, 4 giờ 1 liều. Chấm dứt điều trị nếu xét nghiệm Paracetamol trong huyết tương cho thấy nguy cơ độc hại gan thấp.
- Tác dụng không mong muốn của N - acetylcystein gồm ban da (gồm cả mề đay, không yêu cầu phải ngừng thuốc), buồn nôn, nôn, tiêu chảy, và phản ứng kiểu phản vệ.
- Nếu không có N - acetylcystein, có thể dùng methionin. Ngoài ra có thể dùng than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối, chúng có khả năng làm giảm hấp thụ Paracetamol.

CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO

- Chỉ được sử dụng một lần, bỏ đi phần dung dịch thừa nếu chưa sử dụng hết.
- Không được sử dụng khi dung dịch bị vẩn đục, đổi màu, chứa các phần tử tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoặc túi dịch bị thủng, nắp nhựa và niềng nhôm không còn nguyên vẹn.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

Hạn dùng: 36 tháng (kể từ ngày sản xuất)

Điều kiện bảo quản: nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED

Lô A-1H-CM, KCN Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: